EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL	: HOSPITAL DE SAN CARLOS	N° EGRESO	: 82451
SERVICIO	: UNIDAD EMERGENCIAS		
FECHA	: 13-04-2024		

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: TRINIDAD DEL CARMEN RIQUELME ACU❓A			RUN	: 4.928.576-0
F.Nac	: 12-04-2024	Edad	: 0 AÑO	Género	: Femenino
Dirección	:			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 12-04-2024	Fecha Egreso	: 13-04-2024	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

Compromiso de consciencia transitorio
ITU
AP: HTA, DMT2, ERC, ACV previo, Hipotiroidismo

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Familiar de paciente refiere inicio de sintomatología hace 1 día presentando, acorde a relato, compromiso de consciencia. Según refiere, se encontraba aparentemente obnubilada, capaz de abrir los ojos al llamado con escasa respuesta. En relación al contexto, paciente se encontraba próxima a una estufa a alta temperatura (acorde a relato de familiar). Evento tuvo una duración aproximada de 15 minutos con recuperación espontánea. Acude a servicio de urgencias sin signos de focalización o compromiso neurológico. Se evalúa y evidencia EOC inflamatorio, positivo, por lo que amerita terapia ATB.
Converso caso vía telefónica con neurología sugiriendo que alteraciones y compromiso escasamente pudieran asociarse a algún problema neurológico.
Actualmente paciente en buenas condiciones generales, eupneica, afebril. No impresiona compromiso neurológico. Evolución clínica favorable. Se decide alta médica.
TC Cerebro 12/04
Estudio sin hallazgos intracraneanos de carácter agudo. Infartos antiguos subcortical parietal derecho, mesencéfalo protuberancial postero lateral derecho y cerebeloso izquierdo en territorio de PICA. Cambios involutivos encefálicos dentro de lo esperable para la edad, asociados a signos de microangiopatía en sustancia blanca supratentorial. Ateromatosis cálcica de vasos intracraneanos.

INDICACIONES AL ALTA

1. Traslado a Hosp Domiciliaria

2. Reposo medico relativo
3. Regimen hiposodico, diabético
4. Ceftriaxona 2gr ev día
5. Atorvastatina 20mg vo dia
6. Furosemida 20mg vo c12h
7. Levotiroxina 50mcg vo día
8. Insulina NPH 14-10
9. Paracetamol 1gr vo c8h SOS
10. Bromuro de ipratropio 2 puff cada 8 horas
11. Amlodipino 10mg vo dia
12. Control ex lab 48hrs
13. Rescatar resultado de UCT
14. Avisar eventualidad

andres david velasquez guerra
MEDICO TRATANTE
27124399-5

JEFE SERVICIO